جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال محمد محمد السيد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** التبين **العنوان :** كورنيش النيل
رقم البطاقة : 27706201401501 **رقم التليفون :** 01065611467 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 20-06-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال محمد محمد السيد
National ID: 27706201401501

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Bone scintigraphy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



مينال
محمد محمد السيد
ش خالدبن الوليد-كورنيش النيل
التبين - القاهرة

١٩٧٧/٠٦/٢٠

٢٧٧٠٦٢٠١٤٠١٥٠١

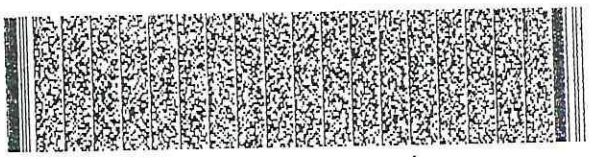
ID1230999



٢٧٧٠٦٢٠١٤٠١٥٠١ ٢٠١٩/٠٨
ربة منزل



انثى مسلمة متزوجة
عثمان محمد عبدالموجود محمود
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/٠٨/٢٧



National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

صحة مصر

05/12/2026

MDT FORM

Name:	Manal منال محمد قنوة	MRN:	10485
Age:	49 Y	ID:	27706201401501
Menopausal Sta	premenopausal	Phone:	01019309122
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	Breast cancer in cousin(paternal side)
CO Morbidity:	none	Reason Of MDT:	

Clinical Data:

BX: ILC

ER: 8/8 PR: 8/8 HER2: 0 KI67: 3%

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

medically free
patient felt a Lt breast mass so she sought medical attention
Sonomammography 7/4/26: Lt breast mass 9x5x4cm
Biopsy: ILC ER 8/8 PR 8/8 HER2 0 (ultra low) KI67 3%
CT-CAP: multi osteolytic lesions confirmed by bone scan

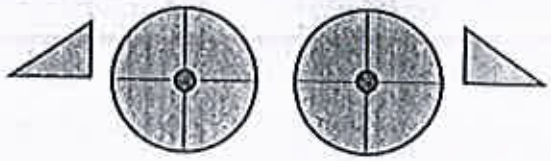
Recommendations:

AI + zoladex + Zometa

MDT Outcome & Plan

Fernara + zoladex + Zometa / 3m

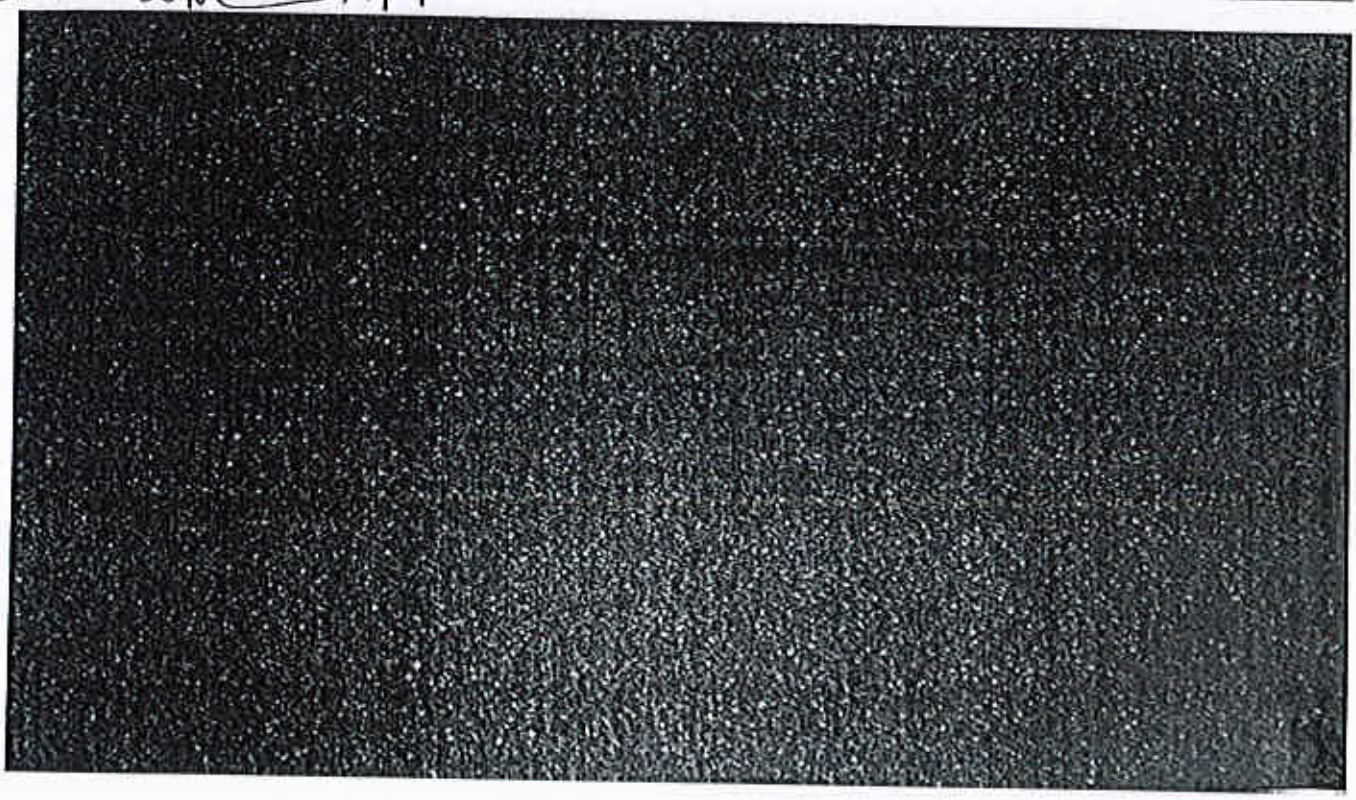
R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ هالة عبد العزيز	د/ محمد قنوة				



Scanned with CamScanner

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: منال محمد محمد السيد **MR. :** 10485	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

Medically free patient presented with a left breast mass; sonomammography on 7/4/26 revealed a 9×5×4 cm lesion. Biopsy demonstrated invasive lobular carcinoma (ILC) with ER 8/8, PR 8/8, HER2 0 (ultra low), Ki67 3%. CT-CAP and bone scan confirmed multiple osteolytic lesions. The case was discussed at MDT.

MDT discussion on 15/06/2026 recommended initiation of endocrine therapy with Femara and Zoladex, and zoledronic acid (Zometa). The patient began Femara and received a 10.8 mg Zoladex depot; the next Zoladex dose is scheduled for 11/08/2026.

On 11/07/2026 the patient was seen for Femara and Zometa after laboratory review; the next Zometa dose is due in 3 months, and Zoladex is due on 6/08.

On 08/09/2026 the MDT decided to continue Zometa every 3 months, discontinue monthly Femara, and arrange a pain consultation for assessment.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : خالد عبد العزيز محمد كمال

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / منال محمد محمد السيد	Request No.	: 13005776
Patient No.	: 27706201401501	Request Date	: 08/04/2026
Path No.	: 937/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass diagnosed "Invasive lobular carcinoma grade 2 with focal LCIS".
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 8/04/2026, at 12:30 pm, cold ischemia time: 20 seconds.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in less than 10% of tumor cells (Ultra-low, score 0+).
- Ki67%: 3%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive lobular carcinoma grade 2, with focal lobular carcinoma in situ.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Ultra-low (score 0+).
- Ki67%: 3%.

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	الأستاذه / منال محمد محمد السيد	Request No.	13005776
Patient No.	27706201401501	Request Date	08/04/2026
Path No.	937/26	Verification Date	21/04/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	48 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low): as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / منال محمد محمد السيد	Request No.	: 13005776
Patient No.	: 27706201401501	Request Date	: 08/04/2026
Path No.	: 937/26	Verification Date	: 21/04/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 48 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass, BIRADs 4c.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 8/04/2026, at 12:30 pm, Cold ischemia time: 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive lobular carcinoma.
* Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
* Lobular carcinoma in situ: Focal LCIS.
* Ductal carcinoma in situ: Absent.
* Perineural invasion: Absent.
* Angioinvasion: Absent.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive lobular carcinoma, Grade 2.
- Focal lobular carcinoma insitu.
- For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

١-٤٨٥

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Manal Mohammed Mohammed
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 04-05-2026 07:33
Medical No. : 366456
Ins.Company : Walkin

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- 47-year-old female patient with history of breast cancer, complains of bone aches; referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 – 3 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

- Multiple foci of intense tracer uptake are noted throughout the axial skeleton. In the spine, involvement includes the cervical, thoracic, and lumbar vertebrae. The bilateral ribs (more prominent on the right side), sternum, bony pelvis, sacrum, and proximal left femur also demonstrate multiple areas of abnormal tracer uptake.
- Bilateral shoulder joints show increased uptake, which may represent a combination of metastatic involvement and degenerative changes.

Impression

- The scan demonstrates multifocal osteoblastic metastatic disease as described.
- Correlation with recent CT or MRI of the spine and pelvis is advised for structural assessment and to evaluate for potential pathological fractures or cord compression.
- Follow up as clinically warranted would be recommended.

Much oblige
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear medicine

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Patient's Name:	**manal mohamed mohamed el sayed**
Date:	**2026-04-28**
Referred by:	Prof.Dr. **et cap+c**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

Spiral Multi-slice Post contrast C.T Examination of the Chest , Abdomen and Pelvis Revealed:

Known case left breast cancer

Chest

- **Left breast architecture distortion for correlation with sonomammography.**
- **Clear both lung fields with no evidence of focal pulmonary infiltration or masses.**
- No evidence of pleural or peri-cardiac sac collection.
- No hilar or mediastinal lymph nodes enlargement.
- Bilateral axillary small lymph nodes od benign looking largest seen at right side 20 mm long axis
- Normal CT appearance of the heart and its great vessels.
- D7& D8 bony osteolytic lesions largest 2.7mm of maximum axial dimention

Abdomen & pelvis

- **Normal size of liver showing homogeneous texture. Parenchymal sizable focal lesions seen.**
- Paten PV and it's main branches , No evidence of intra or extra hepatic biliary radical dilatation.
- Both kidneys are of normal site and size showing good excretory function.
- Normal CT appearance of the GB, pancreas, spleen , suprarenal glands, aorta and IVC.
- No evidence of enlarged retro-crural, porta hepatis or para-aortic lymph nodes.
- No ascites.
- The urinary bladder showing minimal filling with no stone or masses seen.
- The uterus is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions.
- No pelvic masses , collection. or lymphadenopathy.
- Appendicular skeleton shows multiple osteolytic lesions seen affecting D11 , L5.L4, L2 , L1 , Sacral bone and right iliac bone,
- Asscoicted left anterior aceteabulum small millimetric hyperdense scelerotic lesion likely bony island seen.
- Bilateral inguinal lymph nodes look likely reactive inflammatory.

CONCLUSION:

- **Multiple appendicular skeleton dorsolumber , sacral and right iliac osteolytic lesions ?? metastatic for correlation with further metabolic study.**

Much obliged;

Dr. Abubakr Hejazi MSc,FEBR,

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient ID: 94459	Patient Name English: Manal Mohamed Mohamed Alsid
Age:49 years	2026/04/07 12:51:13 PM :Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: Left recent developed lump.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR B).
    - UOQ & outer center area of focal asymmetry& distortion extend from posterior third of the breast to retroareolar region measures 9.4x5x4.3 cm with nipple retraction.
    - Lower quadrants skin edema.

Ultrasound :

- 1-5:00 infiltrative indistinct process with area of shadowing , distortion and altered parenchyma more at 3:00.(area of concern)
- LOQ skin edema reaching 6mm.
- Level I indeterminate node with focal cortical thickness upto3.5mm.

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 4c): 2-5:00 highly suspicious infiltrative process for US guided biopsy

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Dr.Marwa Ramzy, MD, FRCR

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :8-4-2026 جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) منال محمد محمد السيد بطاقة رقم 27706201401501

تليفون رقم: 01065611467

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :8-4-2026

الموظف المختص
محمود عبدالله

افادة-مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 1943291

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]